

利培酮的药物相互作用

陈福新, 秦红群, 董维琼

**摘要:** 介绍非典型抗精神病药利培酮与其它抗精神病药的相互作用, 及与抗抑郁药、锂盐、抗惊厥药、苯二氮草类药、抗高血压、抗生素药的相互作用。

**关键词:** 利培酮; 抗精神病药; 抗抑郁药; 锂盐; 抗惊厥药; 苯二氮草类药

**中图分类号:** R749.053 **文献标识码:** A **文章编号:** 1005-3220(2005)06-0373-02

对利培酮的药物相互作用进行综述如下。

1 与其它抗精神病药的相互作用

1.1 氯氮平 有关利培酮与氯氮平合用问题, 目前仍然存在争议。一些学者认为二者的药理作用有一定的相似性, 合用后治疗作用未必增加, 但是粒细胞缺乏等严重并发症依然存在, 加之新一代抗精神病药临床应用应遵守单一原则, 不主张合并用药<sup>[1]</sup>。而有的学者则认为单一用药经正规治疗无效或者疗效不明显时, 合用能够产生协同作用, 或至少不冲突; 可合并试用<sup>[2]</sup>。

谢聪等<sup>[3]</sup>随机将 40 例精神分裂症患者分成利培酮合用氯氮平组和利培酮单用组, 采用简明精神病评定量表(BPRS)和副反应量表(TESS)评定疗效和不良反应, 两组疗效差异无显著性, 不良反应各有不同。张毅等<sup>[4]</sup>对 26 例难治性精神分裂症患者, 给予氯氮平合用利培酮, 疗程 8 周, 总有效率 65.3%, 阳性与阴性症状量表(PANSS), 阳性、阴性症状及一般精神病理症状分治疗前后差异均有显著性, TESS 总分治疗前后无显著变化, 作者认为氯氮平治疗疗效不佳的难治性精神分裂症患者合并利培酮治疗疗效较好, 安全性较高。李俊宝等<sup>[5]</sup>对 52 例难治性精神分裂症患者采用利培酮合并小剂量氯氮平治疗, 也有类似结果。

但利培酮对 5-羟色胺 2(5-HT<sub>2</sub>)和多巴胺 D<sub>2</sub> 受体均有拮抗作用, 而氯氮平对 5-HT 和多巴胺能同样有作用, 二者合用可竞争结合受体, 导致不良反应增加。David<sup>[6]</sup>认为利培酮为 CYP2A6 代谢的药物, 可竞争性抑制药物代谢酶的活性, 减少氯氮平的清除, 使氯氮平血药浓度成倍增加, 二者合用可增加氯氮平中毒的危害和不良反应。有报道<sup>[7]</sup>利培酮合用氯氮平可引起恶性综合征。师建国等<sup>[8]</sup>对 91 例首发精神分裂症患者分为单用利培酮组和利培酮与氯氮平合用组, 结果发现合用并不能提高疗效, 反而加重不良反应。唐英等<sup>[9]</sup>对 63 例患者进行血钾分析, 发现单用利培酮血钾水平无显著变化, 而利培酮联用氯氮平时血钾升高。

我们认为氯氮平最好单一使用, 除非是对一些难治性病例, 方可在严密监测下试用。

1.2 其它抗精神病药 王高华等<sup>[10]</sup>认为对中度兴奋激惹及重度兴奋状态的患者, 可以采用利培酮联用氯丙嗪或氟哌啶醇以控制症状。有报道<sup>[11]</sup>将锥体外系反应(EPS)发生率高的药物(如氟哌啶醇、奋乃静等)更换成利培酮后, 有些不良反应会加重。有 1 例精神分裂症患者, 以利培酮日量 2 mg

维持治疗, 合并使用舒必利日量 400 mg, 第 4 天后双下肢肌张力减弱, 肌力Ⅳ级, 走路及坐起困难, 停药后恢复<sup>[12]</sup>。另 1 例原用氯丙嗪, 加用利培酮 1 mg, 2 h 后出现谵妄<sup>[13]</sup>。故利培酮最好单独使用, 药物互换时应缓慢递减原药, 尤其是高效价药物; 联用者应注意不良反应。

2 与抗抑郁药的相互作用

2.1 三环类抗抑郁药 利培酮合并三环类抗抑郁药使用, 可导致直立性低血压, 应慎用, 并注意监测血压。

2.2 氟西汀 李刚等<sup>[14]</sup>将 67 例抑郁症患者随机分成两组, 分别予氟西汀与氟西汀合并利培酮治疗 6 周, 认为利培酮合并氟西汀治疗抑郁症不仅疗效好, 起效快, 且无不良反应, 耐受性好。利培酮为细胞色素 P450 酶代谢的药物, 而多数抗抑郁药尤其是选择性 5-HT 再摄取抑制剂(SSRI)类有抑制 CYP450 酶催化代谢的作用, 二者合用会影响利培酮的清除率与半衰期, 使血药浓度升高, 合用时需适当减少剂量, 注意相互作用。

3 锂盐

Tohen 等<sup>[15]</sup>在服用锂盐加利培酮治疗的 12 例患者中, 8 例耐受性和疗效均较好, 但也有发热、肌酸磷酸激酶含量及白细胞升高等不良反应。也有引起谵妄的报道。Small 等<sup>[16]</sup>认为二者联用优于氯丙嗪与碳酸锂联用, 与电休克治疗联用碳酸锂疗效相当。

4 与抗惊厥药的相互作用

4.1 丙戊酸 仅有个案显示联用有效, 最好勿联用。

4.2 卡马西平<sup>[16]</sup> 卡马西平是肝药酶 P450 酶诱导剂, 二者合用可增加利培酮的清除率, 需注意其相互作用, 尽量避免联用。

5 与苯二氮草类药的相互作用

王高华等<sup>[10]</sup>建议对于轻度兴奋状态患者可联用利培酮与苯二氮草类药, 对于中重度兴奋激越者可肌内注射地西泮、劳拉西泮或氯硝西泮等。杨小男等<sup>[17]</sup>将 100 例精神分裂症患者随机分成两组, 分别给予利培酮联用氯硝西泮或氯氮平单用, 疗程为 6 周, 结果显示二者合用能有效治疗精神分裂症急性期兴奋, 不良反应少, 安全性好。

6 与其它药物的相互作用

利培酮与苯海索合用, 可减少和缓解 EPS<sup>[18]</sup>。利培酮与降压药合用时, 可加强降压效应, 联用时宜适当减少降压药剂量, 同时注意监测血压变化。与抗组织胺药合用, 可出现过度镇静。与抗生素如氯霉素、环丙沙星、红霉素、甲硝唑等合用具有酶抑制作用, 合并用药会抑制药物代谢酶, 使利培酮效果增强, 作用时相延长, 甚至产生蓄积作用, 合用时宜适

作者单位: 671000 云南省大理州第二人民医院(陈福新, 董维琼); 云南大理州人民医院(秦红群)

当减少药物剂量。西咪替丁与 P450 酶有较强的亲和力,能抑制酶的活性,合用宜减少利培酮剂量。利福平、泼尼松、D860 等具有酶诱导作用,合用会加强药物代谢,降低血药浓度,使治疗作用下降或失败,病情恶化,停用又可能会提高利培酮血药浓度而出现中毒症状,应引起重视。一些  $\beta$  阻滞剂会增加利培酮的血药浓度,提示可能会增加不良反应,合用时应注意观察。

参考文献:

[1] 江开达,刘登堂.利培酮与氯氮平的合用[J].临床精神医学杂志,2003,13,61.  
[2] 吴天诚.利培酮与氯氮平的合用[J].临床精神医学杂志,2003,13,61-62.  
[3] 谢聪,倪小玲.单独用利培酮及其联合氯氮平治疗精神分裂症的疗效观察[J].四川精神卫生,2002,15,96-97.  
[4] 张毅,宋立升.氯氮平合并利培酮治疗难治性精神分裂症[J].临床精神医学杂志,2000,10,87-88.  
[5] 李俊宝,张向英.维思通联合小剂量氯氮平治疗难治性精神分裂症的疗效观察[J].四川精神卫生,2002,15,103.  
[6] David Taylor. Pharmacokinetic interactions involving clozapine [J]. Br Psychiatry, 1997, 171, 109.  
[7] 陈福新,赵振声.氯氮平的相互作用[J].中国医院药杂志,2000,20,233-235.

[8] 师建国,行养玲,杨旭.利培酮与氯氮平联用治疗精神分裂症对照研究[J].临床精神医学杂志,2002,12,154-155.  
[9] 唐英,黄自勇.利培酮对血钾的影响[J].临床精神医学杂志,1999,9,63.  
[10] 王高华,王惠玲.利培酮与兴奋症状[J].临床精神医学杂志,2002,12,63.  
[11] 汪卫华,张英,王焕林.利培酮临床运用评价[J].临床精神医学杂志,1997,7,229-231.  
[12] 编辑部综合.抗精神病药的副反应(肌张力减弱)[J].临床精神医学杂志,2000,10,251.  
[13] 编辑部综合.抗精神病药的副反应(谵妄)[J].临床精神医学杂志,2000,10,251.  
[14] 李刚,梁海翔.利培酮联合氟西汀与氟西汀单独治疗抑郁症的效果比较[J].四川精神卫生,2002,15,92-93.  
[15] 彭斌.心境稳定剂的联合应用[J].国外医学精神病学分册,1998,25,167-171.  
[16] 刘铁榜.非典型抗精神病药在躁狂症治疗中的应用[J].国外医学精神病学分册,2000,27,1-4.  
[17] 杨小男,梅其一.利培酮合并氯硝西洋治疗精神分裂症对照研究[J].临床精神医学杂志,2004,14,163.  
[18] 范俭雄,隋毓秀,陈震华.维思通治疗精神分裂症患者 145 例报告[J].临床精神医学杂志,1999,9,32-33.

(收稿日期:2005-04-19)

•临床研究•

60 例躯体形式障碍临床特征分析

范红

关键词： 躯体形式障碍； 临床特征

中图分类号： R749.7      文献标识码： B      文章编号： 1005-3220(2005)06-0374-01

我们对躯体形式障碍患者的临床资料作一分析,现将结果报告如下。

1 对象和方法

系 2002 年至 2004 年四川大学华西医院精神科和我院住院及门诊患者,共 60 例;均符合中国精神障碍分类与诊断标准第 3 版躯体形式障碍的诊断标准。

采用汉密尔顿抑郁量表(HAMD)及自编调查问卷(内容包括:发病年龄、性别、文化程度、职业、起病因素、就医情况、病程、临床表现及治疗情况)进行评定与调查。

2 结果

60 例中男 21 例,女 39 例;发病年龄 18~60 岁,平均 38.5 岁;病程 3 个月~22 年,平均 6 年;小学文化 19 例,中学 27 例,大专及以上 14 例;工人 16 例,农民 18 例,教师 12 例,科技及管理人员 8 例,无业及其他 6 例。有明显起病诱因者 39 例。

临床表现为一种或多种躯体疾病症状 12 例(20%),头晕头痛及皮肤感觉异常 18 例,呼吸、心血管、消化系统及自主神经系统症状 26 例,泌尿生殖及其他器官症状 4 例,其他

12 例。首次发病就诊于综合医院 46 例,有过 3 次以上就诊记录,并作过不止 1 次肾功能、胃镜、CT、MRI 等检查 54 例,伴抑郁症状 15 例。

在采用心理治疗的同时给予氯丙嗪联合氯硝西洋或阿普唑仑治疗 36 例,帕罗西汀联合氯硝西洋或阿普唑仑 16 例,氟西汀联合氯硝西洋 4 例;4~6 周后症状逐渐缓解,用药 3 个月后减量,维持 6~9 个月,半年后随访复发 5 例。

3 讨论

本研究结果显示,躯体形式障碍发病年龄平均 38.5 岁,女性较多,多有明显诱因,这与中年人群社会经济竞争、工作生活压力大有关。但在做出这些诊断时应持谨慎态度,做好鉴别诊断<sup>[1]</sup>。患者大部分(90%)在综合医院就医检查,与报道相符<sup>[2]</sup>,反复检查及治疗占用大量的医疗资源使内科医生无所适从。患者经药物和心理治疗,一般预后较好。

参考文献:

[1] 王东林,吴彩云,吴爱勤.躯体化障碍与抑郁症的临床特征比较[J].临床精神医学杂志,2000,10,4.  
[2] 王春芳.关于“躯体形式障碍”的诊断[J].临床精神医学杂志,2004,14,63.

(收稿日期:2005-06-06)